

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099035-33.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NITERÓI

RECORRIDO: MIGUEL AURELIO SOUSA NOBRE

RECORRIDO: MARIA CATIA FAENCA NOBRE

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MELATONINA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. SUBSTÂNCIA MANIPULADA EM FARMÁCIA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. SUBSTÂNCIA INDICADA PARA O QUADRO CLÍNICO DE INSÔNIA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5099035-33.2024.4.02.5101

510015326439 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099035-33.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NITERÓI

RECORRIDO: MIGUEL AURELIO SOUSA NOBRE

RECORRIDO: MARIA CATIA FAENCA NOBRE

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pelo Município de Niterói, em face da decisão do juízo de origem, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

"Trata-se de ação na qual a parte autora requer o fornecimento dos seguintes medicamentos e insumos:

(i) Óleo Roxo de Canabidiol - CBD 4%, em frascos mensais de 30 ml;

(ii) Melatonina 2,5 mg;

(iii) fraldas.

Alega que "(...) atualmente com 07 anos completos, representado na presente Ação por sua genitora, tem quadro clínico grave, decorrente de diagnóstico de "autismo atípico", CID 84.1, secundário a uma doença neurológica, a "encefalopatia não especificada", CID G 93.4."

Sustenta que "Já fez o autor uso de medicamentos padronizados e fornecidos pelo SUS, que, porém, não surtiram o almejado efeito de melhora na saúde e qualidade de vida do autor. A partir da ineficácia, no caso concreto, dos medicamentos ordinariamente ofertados pelo Sistema Único de Saúde, iniciou o tratamento com Canabidiol, ou Óleo rico em CBD (/Canabidiol) 4%, utilizando 03 gotas de 12 em 12 horas e 01 comprimido de Melatonina 2 Mg de 12 em 12 horas."

Os autos foram remetidos ao NAT, que ofereceu Parecer ao Evento 36, prestando as seguintes informações:

"Os estudos relatam que a falta de testes rigorosos deixa incertezas quanto ao CBD como uma opção terapêutica viável para transtornos do neurodesenvolvimento. Embora a literatura existente destaque várias descobertas promissoras, a adequação do CBD na melhoria dos principais domínios de sintomas em transtornos do neurodesenvolvimento está longe de ser resoluta⁵."

"O conhecimento atual sobre a eficácia e a segurança da medicina baseada em Cannabis em psiquiatria ainda é escasso. Apenas em um pequeno número de estudos, é sugerido que o CBD melhora o transtorno de ansiedade social. Nota-se que os dados apresentados se referem a pacientes adultos, além de um pequeno número de estudos sobre TEA. Consequentemente, em crianças, os produtos à base de Cannabis devem ser usados com cautela, pois há poucos dados disponíveis sobre eficácia e segurança em pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento nessa faixa etária¹⁰."

"não foi verificada por este Núcleo evidência científica robusta que possibilite inferir acerca da eficácia e segurança da utilização do pleito Canabidiol no tratamento de pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista e encefalopatia."

"Informa-se que a substância Canabidiol não foi avaliada pela Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para o tratamento do transtorno do espectro autista."

"Segundo o referido PCDT, não foi possível preconizar o uso de Canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA com base nos estudos clínico e observacionais encontrados¹²."

Em relação à Melatonina, o Núcleo informou que:

"(...) observa-se a redução da latência para início do sono e os despertares, assim como melhora o humor e o comportamento diurno. Sua eficácia em crianças com transtorno do déficit de atenção e transtorno do espectro autista (TEA) tem sido relatada em diversos estudos. A dose aconselhada é de 0,5 - 3mg em crianças. Em doses habituais, os efeitos colaterais são irrelevantes, não há interferência no uso de medicamentos antiepilépticos, na produção de melatonina endógena ou no desenvolvimento puberal. Ademais, não causa dependência¹³. Isso posto, em verdade, a Melatonina prescrita ao Autor, que apresenta diagnóstico de TEA, na concentração de 4mg/dia, está indicada."

Quanto às fraldas descartáveis, informou o NAT que estão indicadas ao manejo do quadro clínico da parte autora.

Conforme o Parecer, as fraldas, a melatonina e o canabidiol não são disponibilizados pelo SUS.

O NAT verificou que o Autor não está cadastrado no CEAF para a retirada do medicamento padronizado Risperidona.” e que **não existem opções terapêuticas, no âmbito do SUS, que possam substituir os itens pleiteados.**”

Ainda do Parecer do NAT, consta que, “Conforme a RDC Nº 327, de 9 de dezembro de 2019, o Canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. A indicação e a forma de uso dos produtos à base de Cannabis são de responsabilidade do médico assistente¹².”

Verifica-se, portanto, que apesar de o PCDT, não preconizar o uso de Canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA, o Núcleo informa que não existem opções terapêuticas que possam substituir os itens pleiteados e que o Canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro.

Assim, tem-se a necessidade de maiores esclarecimentos a respeito da indicação do Canabidiol no caso dos autos.

Quanto à Melatonina e às fraldas, informou o Núcleo que estão indicadas ao tratamento da patologia que acomete a parte autora. No entanto, não há nos autos prescrição indicando o número de fraldas necessário. Do atestado de Evento 1, anexo2, fl. 13, consta a necessidade das fraldas, mas não traz a quantidade.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Uma vez observados os requisitos autorizadores da liminar, como ocorre no caso dos autos, esta deve ser deferida.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os réus, inicialmente através do Município de Niterói, forneçam Melatonina 2,5 mg, nos termos da prescrição juntada ao Evento 1, anexo3, fl. 3, no prazo de 20 dias, sob pena constrição de valores para a aquisição do suplemento.

Intime-se o Município de Niterói para que cumpra essa decisão no prazo acima determinado.”

Em seu recurso, o Município de Niterói afirma que a melatonina encontra-se proibida pela Anvisa para o uso infantil. Afirma tratar-se de tratamento experimental e que não foi especificado quais medicamentos foram testados no caso do Autor. Subsidiariamente, sustenta que houve o direcionamento equivocado ao município, já que por se tratar de tratamento experimental, sem registro na Anvisa deveria o cumprimento ser direcionado à União.

Efeito suspensivo indeferido no Evento 3.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que, tendo em vista que nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde, discute-se a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal à luz do tema 1234 do STF - o qual não se aplica na presente demanda, já que se está diante de medicamento sem registro na Anvisa, como veremos abaixo por questão de valor, embora exista evidência científica robusta da efetividade.

Outrossim, evidenciada a competência da Justiça Federal pelo tema 500 do STF. Neste sentido, o próprio tema 1234 afirma :

(...) “II Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) **Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema”** grifos nossos

Além disso, cumpre destacar também que em relação ao tema 1234 (RE 1366243) ainda que se tratasse de medicamento com registro na anvisa, com relação à competência, houve modulação de efeitos, afastando a sua incidência até a publicação do resultado do julgamento que ocorreu em 11/10/2024.

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

De acordo com o formulário médico juntado aos autos o Autor, portador de encefalopatia não especificada e autismo atípico, precisaria fazer o uso de melatonina para controle dos sintomas, especialmente insônia (evento 1, ANEXO5 pag. 8/9):

EM NÃO TENDO SIDO PRESCRITO MEDICAÇÃO PADRONIZADA, O QUE JUSTIFICA A PRESCRIÇÃO DESSE MEDICAMENTO ESPECIFICADAMENTE? FAVOR ESCLARECER JUSTIFICADAMENTE.

Paciente tem diagnóstico de autismo secundário a uma doença neurológica. Devido ao quadro tem baixa capacidade de comunicação, interação social, agitação psicomotora intensa e baixa tolerância a estímulos externos. Não teve boa resposta com o uso das medicações padronizadas pelo SUS apresentando controle inadequado dos sintomas e muitos efeitos colaterais. Se mantém estável com prescrição atual.

HÁ PRAZO OU URGÊNCIA PARA INÍCIO DA INGESTÃO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS?

QUAL O RISCO NA DEMORA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS: MORTE, LESÃO IRREVERSÍVEL OU IRREPARÁVEL?

QUAIS OS DANOS QUE, EVENTUALMENTE, SUA NÃO INGESTÃO PODERIA CAUSAR AO PACIENTE?

A não ingestão pode regredir o paciente nas questões de agitação, agressividade contra si e terceiros, insônia e dificuldades na esfera da socialização, comunicação e convivência.

O NAT, em seu parecer, afirmou que a melatonina não tem registro na ANVISA por ser uma substância manipulada em farmácia, mas afirmou que está indicado para o quadro clínico do Autor. Vejamos:

8. No que tange à **Melatonina**, observa-se a redução da latência para início do sono e os despertares, assim como melhora o humor e o comportamento diurno. Sua eficácia em crianças com transtorno do déficit de atenção e **transtorno do espectro autista (TEA)** tem sido relatada em diversos estudos. A dose aconselhada é de 0,5 – 3mg em crianças. Em doses habituais, os efeitos

colaterais são irrelevantes, não há interferência no uso de medicamentos antiepilépticos, na produção de **melatonina** endógena ou no desenvolvimento puberal. Ademais, não causa dependência¹³. Isso posto, em verdade, a **Melatonina** prescrita ao Autor, que apresenta diagnóstico de **TEA**, na concentração de 4mg/dia, **está indicada**.

9. Cumpre esclarecer que a **Melatonina 2mg** trata-se de **formulação magistral**. Ela **deverá ser manipulada** diretamente pelo profissional farmacêutico, a partir das fórmulas escritas no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA, ou, ainda, **a partir de uma prescrição de profissional habilitado que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar**¹⁴. Acrescenta-se que as formulações farmacêuticas são prescritas e manipuladas em uma dosagem ou concentração específica para cada paciente, sendo, portanto, de uso individual e personalizado¹⁵.

11. No que se refere à disponibilização no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS, cabe informar que o insumo **fraldas descartáveis** e os produtos **Melatonina 2mg** e **óleo rico em Canabidiol 4%** **não integram** nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) dispensados através do SUS, no âmbito do Município de Niterói e Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe seu fornecimento a nenhuma das esferas de gestão do SUS.

17. Ademais, cumpre esclarecer que **não existem opções terapêuticas**, no âmbito do SUS, que possam substituir os itens pleiteados.

Como se observa da manifestação do órgão técnico não existem alternativas terapêuticas no SUS para o produto concedido, isto é, a melatonina.

A necessidade do insumo está devidamente demonstrada pelo assistente técnico, diante do quadro de agitação e insônia sofrida pelo Autor.

No próprio artigo científico¹ referenciado pelo NAT, assim consta:

3) Transtorno do espectro autista (TEA)

TEA é composto por distúrbios do neurodesenvolvimento (doenças pervasivas, Asperger) caracterizados por significativa disfunção na interação social e comunicação (linguagem). Distúrbios do sono são comuns nessa população e têm efeitos graves na qualidade de vida da criança afetada e de sua família. Restrição de sono tem sido associada a maior frequência de estereotípias e piores escores de gravidade. A queixa de insônia caracterizada por longa latência para iniciar o sono, resistência para dormir, redução da eficiência do sono e despertares noturnos é de grande preocupação para

os pais. Nas crianças menores, observa-se adicionalmente maior prevalência de insônia comportamental (problemas de associação para início do sono e falta de limites).²⁷

A ANVISA em documento sobre a melatonina afirma que no cenário internacional a melatonina é usada para tratamento da insônia, inclusive em crianças e adolescentes autistas.²

As principais indicações terapêuticas aprovadas para a melatonina são:

- auxiliar no tempo total de sono ou na qualidade do sono em pessoas sofrendo de restrição ou rotina alterada de sono;
- auxiliar na prevenção e redução dos efeitos do jet lag;
- auxiliar a reduzir o tempo de adormecimento em pessoas que demoram a dormir;
- auxiliar a ajustar o ritmo circadiano do corpo;
- indutor do sono para alívio da insônia ocasional;
- regulador do ciclo vigília-sono;
- alívio sintomático de quadros temporários de insônia associados a estados de inquietação;
- tratamento a curto prazo da insônia primária em pacientes com 55 anos ou mais;
- tratamento da insônia recorrente em crianças e adolescentes (2 a 18 anos) com transtorno do espectro do autismo ou Síndrome de Smith-Magenis.

As dosagens terapêuticas aprovadas variam de 0,1 mg no Canadá para auxiliar no tempo total de sono até 5 mg na União Europeia para o tratamento da insônia recorrente em crianças e adolescentes (2 a 18 anos) com transtorno do espectro do autismo ou Síndrome de Smith-Magenis.

Ressalto que a proibição mencionada pelo Município de Niterói refere-se ao uso de melatonina em suplemento alimentar³

Anvisa proíbe o suplemento alimentar Soninho Perfeito Melatonina Kids

A melatonina não é autorizada para uso em suplementos alimentares destinados a crianças e adolescentes.

Publicado em 24/08/2023 09h48 | Atualizado em 24/08/2023 15h43

Compartilhe: [f](#) [in](#) [📞](#) [📧](#)

A Anvisa proibiu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso do suplemento alimentar Soninho Perfeito Melatonina Kids, fabricado pela empresa M.R. Omed Indústria Farmacêutica Ltda., CNPJ: 32784492/0001-40, e determinou o seu recolhimento do mercado.

A proibição foi publicada em 23/8/2023, por meio da [Resolução - RE 3148, de 22 de agosto de 2023](#).

Suplementos alimentares são destinados a pessoas saudáveis, sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticas em complemento à alimentação.⁴ Não se prestam a tratar ou curar doenças.

No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, a 8.^a Turma Recursal já assim firmou seu entendimento:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102."

Apesar de não ser um produto padronizado, tendo em vista que o Município é responsável pela atenção primária ao cidadão e que se trata de produto manipulado em farmácia de valor pouco expressivo, entendo que seria de atribuição do Município, vez que se trata de remédio especialmente para a insônia, assim como são os medicamentos com esta finalidade e cuja ineficácia foi atestada por médico (evento 1, ANEXO5 pag. 8/9 autos originários).

Assim, a decisão não deve ser alterada. O que não impede eventual redirecionamento aos outros entes em caso de descumprimento.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.

1. <https://www.scielo.br/j/jped/a/JjhmCp5V43b3vPBrVJRX6sp/?format=pdf&lang=pt>

2. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/proposta-de-consulta-publica-inclui-a-melatonina-como-constituente-autorizado/analise-da-seguranca-e-eficacia-da-melatonina-versao-para-publicacao.pdf>

3. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/anvisa-proibe-o-suplemento-alimentar-soninho-perfeito-melatonina-kids>

4. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/suplementos-alimentares#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20um%20suplemento,probi%C3%B3ticos%20em%20complemento%20%C3%A0%20alimenta%C3%A7%C3%A3o.>